

医药生物

多款减肥药亮相 2025 ADA, 重点关注 AMYR 与 ActRII 靶点

2025 年 06 月 29 日

——行业周报

投资评级：看好（维持）

余汝意（分析师）

余克清（分析师）

汪晋（分析师）

yuruyi@kysec.cn

yukeqing@kysec.cn

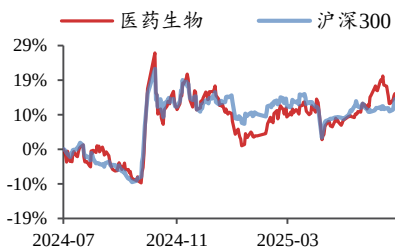
wangjin3@kysec.cn

证书编号：S0790523070002

证书编号：S0790525010002

证书编号：S0790525060003

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《关注高质量减重赛道近期积极进展——行业周报》-2025.6.22

《SYS6010:广谱抗肿瘤大品种，早期 NSCLC 数据优异——行业周报》-2025.6.15

《管线布局迈入收获期，2025 开启国产流感新药元年——行业深度报告》-2025.6.15

● 多款减肥药亮相 2025 ADA, 重点关注新靶点与新技术领域

2025 ADA 大会上，多个潜在在研管线展示其减重适应症最新临床数据。从技术形式看，减脂增肌、口服药物、超长效药物有望成为未来减肥药布局新方向；从靶点本身看，以礼来的 eloralintide 为代表的 AMYR 靶向药物与 Bimagrumab 为代表的 ActRII 靶向药物展现出优异的临床数据，有望成为下一代布局的核心靶点。

● 特殊靶点组合疗法：协同机制提升疗效，减脂增肌高质量减重

(1)AMYR 靶向药物：以礼来的 eloralintide 与罗氏的 Petrelintide 为代表的 AMYR 单靶药物整体疗效优异，安全性整体优于 GLP-1；同时，诺和诺德也开发了 GLP-1 与 Amylin 的复方制剂 CagriSema 与双靶多肽药物 Amycretin-NN9487，相较于司美格鲁肽单药减重效果均大幅提升。随着长效化、口服化及多靶点联用技术的成熟，AMYR 有望成为下一代减肥药物的核心靶点。

(2) ActRII 靶向药物：“减脂增肌+代谢修复”有望成为未来减重领域的新标准，与一些特殊靶点的协同联用也有望成为高质量减重下一阶段的发展方向。礼来在 2025 ADA 会议上公布其 ActRII 靶向药物 Bimagrumab 治疗减重的 IIb 期临床数据，结果表明 Bimagrumab 单药 100%的减重均来自于脂肪，总瘦体重增加了 2.5%；与司美格鲁肽联用时能够有效协同实现体重降低，92.9%的减重来自脂肪。安全性方面，常见不良反应包括肌肉痉挛、腹泻、痤疮等，整体可控。

● 口服与超长效药物：减重降糖领域下一个风口，有望打开新增量市场

自礼来口服小分子 Orforglipron 的临床数据公布后，口服药物的关注度持续提升，我们预期将成为减重降糖领域下一个风口，有望打开新的增量市场。长周期给药是另一条差异化竞争路线，安进的双靶点长效制剂 Maridebart cafraglutide 于 2025 ADA 大会展示其 4 周给药与 8 周给药详细数据，52 周时，420 mg Q4W 与 Q8W (no dose escalation)较基线体重下降分别约 18.9%/17.7%(安慰剂调整后 16.3%/15.1%)，长周期给药间隔依然保持良好的临床疗效。

● 推荐标的

推荐标的：制药及生物制品：恒瑞医药、华东医药、三生制药、人福医药、恩华药业、信达生物、再鼎医药、百利天恒、泽璟制药-U、诺诚健华、科伦博泰生物-B、三生国健、康诺亚-B、一品红、海思科、艾力斯、艾迪药业、和黄医药、京新药业、健康元；CXO：药明康德、药明合联、泰格医药、药明生物、博腾股份、泓博医药；科研服务：毕得医药、百普赛斯、皓元医药、昊帆生物、海尔生物、奥浦迈、阿拉丁；中药：东阿阿胶、江中药业、天士力、济川药业、羚锐制药、悦康药业、方盛制药、佐力药业；原料药：普洛药业、健友股份、华海药业、奥锐特、博瑞医药；医疗器械：迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、英科医疗、万孚生物、可孚医疗、圣湘生物、康拓医疗；医疗服务：爱尔眼科、通策医疗、美年健康、海吉亚医疗、锦欣生殖；零售药店：益丰药房。

● 风险提示：政策落地不及预期、行业整合不及预期、行业竞争格局恶化等。

目 录

1、多款减肥药亮相 2025 ADA，重点关注 AMYR 与 ActRII 靶点	3
1.1、特殊靶点组合疗法：协同机制提升疗效，减脂增肌高质量减重	3
1.1.1、AMYR：多款产品临床数据亮眼，有望成为下一代核心靶点	3
1.1.2、ActRII：Bimagrumab 初步 POC，打开高质量减重新布局方向	5
1.2、口服药物：减重降糖领域下一个风口，有望打开新增量市场	5
1.3、超长效药物：安进 Maridebart cafraglutide 长周期给药疗效优异	6
1.4、单靶/多靶 GLP-1：减重降糖基石药物，持续追求疗效与安全性提升	7
2、6 月第 4 周医药生物上涨 1.6%，医院子板块涨幅最大	9
2.1、板块行情：本周医药生物上涨 1.6%，跑输沪深 300 指数 0.35pct	9
2.2、子板块行情：医院板块涨幅最大，线下药店涨幅最小	9
3、风险提示	11

图表目录

图 1：2025 ADA 大会上，多款 AMYR 靶向药物数据读出，整体疗效优异安全性良好	3
图 2：针对肥胖患者 eloralintide 疗效数据亮眼	4
图 3：eloralintide 单药消化道不良反应发生率较低	4
图 4：GLP-1R/ Amylin 双靶多肽药物 Amycretin-NN9487 早研数据疗效优异	4
图 5：重点关注 Amycretin-NN9487 后续胃肠道相关不良反应	4
图 6：Bimagrumab 与 Sema 能够实现有效协同	5
图 7：Bimagrumab 不良反应整体可控	5
图 8：口服 GLP-1RA 类药物的开发为提升患者依从性提供了新的思路，有望打开新的增量市场	6
图 9：Maridebart cafraglutide 长周期给药间隔依然保持良好的临床疗效	7
图 10：作为减重降糖领域的基石药物，多款单靶与多靶 GLP1R 靶点药物也在 2025 ADA 大会披露其最新临床数据	8
图 11：6 月医药生物指数下跌 0.35%（单位：%）	9
图 12：6 月第 4 周医药生物上涨 1.6%（单位：%）	9
图 13：医院板块涨幅最大，线下药店涨幅最小	10
表 1：6 月以来血制品和医疗耗材板块涨幅领先	10
表 2：子板块中个股涨跌幅（%）前 5	11

1、多款减肥药亮相 2025 ADA, 重点关注 AMYR 与 ActRII 靶点

2025 ADA 大会上，多个潜力在研管线展示其减重适应症最新临床数据。从技术形式看，减脂增肌、口服药物、超长效药物有望成为未来减肥药布局新方向；从靶点本身看，以礼来的 eloralintide 为代表的 AMYR 靶向药物与 Bimagrumab 为代表的 ActRII 靶向药物展现出优异的临床数据，有望成为下一代布局的核心靶点。

1.1、特殊靶点组合疗法：协同机制提升疗效，减脂增肌高质量减重

1.1.1、AMYR：多款产品临床数据亮眼，有望成为下一代核心靶点

胰淀素（Amylin）是由 37 个氨基酸组成的多肽激素，由胰腺 β 细胞分泌并与胰岛素协同释放，通过激活中枢神经系统和外周器官的 Amylin 受体（AMYR），抑制肠胃蠕动、延缓胃排空，从而减少食欲。AMYR 靶向药物疗效优异，同时能够规避 GLP-1 类药物的主要副作用（胃肠反应、肌肉流失等）。随着长效化、口服化及多靶点联用技术的成熟，AMYR 有望成为下一代减肥药物的核心靶点。

2025 ADA 大会上，多款 AMYR 靶向药物数据读出。以礼来的 eloralintide 与罗氏的 Petrelintide 为代表的 AMYR 单靶药物整体疗效优异，安全性整体优于 GLP-1；同时，诺和诺德也开发了 GLP-1 与 Amylin 的复方制剂 CagriSema 与双靶多肽药物 Amycretin-NN9487，相较于司美格鲁肽单药减重效果均大幅提升。

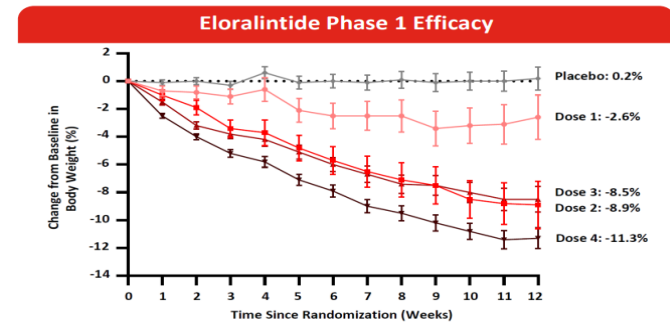
图1：2025 ADA 大会上，多款 AMYR 靶向药物数据读出，整体疗效优异安全性良好

管线	公司	靶点	技术形式	给药途径	临床试验编号	临床分期	基线	试验分组	给药方案	N	用药周期	体重减少百分比	相对安慰剂减少	安全性
Amycretin-NN9487	诺和诺德制药 (orig.)	AMYR GLP1R	多肽	皮下	NCT06064006	I期	BMI 30.0-33.1 kg/m2	60mg组	0-32w爬坡后维持 60mg QW	17	36周	24.3%	23.2%	试验组TEAE比例整体与安慰剂组相似，高剂量组消化道相关AE略高于安慰剂组（60mg 94% vs 80%），神经系统相关AE略高于安慰剂组（60mg 77% vs 40%）
								20mg组	0-24w爬坡后维持 20mg QW	34		22.0%	23.9%	
								5mg组	0-16w爬坡后维持 5mg QW	16		16.2%	18.5%	
								1.25mg组	0-8w爬坡后维持 1.25mg QW	16		9.7%	11.7%	
								安慰剂组	安慰剂	18				
eloralintide	礼来 (orig.)	AMYR	多肽	皮下	NCT06345066	I期	BMI 27-43 kg/m2	Dose 1	QW	100	12周	2.6%	2.4%	试验组AE：食欲减退19%，头痛12%，疲乏11%；腹泻10%，恶心8%，呕吐4%，大多数不良反应均未轻度。1例SAE与治疗无关
								Dose 2	QW			8.5%	8.3%	
								Dose 3	QW			8.9%	8.7%	
								Dose 4	QW			11.3%	11.1%	
								安慰剂组	QW			0.2%		
Petrelintide	Zealand (orig.)/罗氏 (lic.)	AMYR	多肽	皮下	NCT05613387	I期	BMI 29 kg/m², 体重92 kg	2.4mg组	爬坡至2.4mg QW	48	16周	4.8%	3.1%	只有1例患者因胃肠道不良事件而停药，只有这一名参与者出现呕吐
								4.8mg组	爬坡至4.8mg QW			8.6%	6.9%	
								9.0mg组	爬坡至9.0mg QW			8.3%	6.6%	
								安慰剂组	安慰剂			1.7%		
CagriSema (Cagrilintide+司美格鲁肽)	诺和诺德制药 (orig.)	GLP1R +AMYR	多肽	皮下	NCT05567796	III期	BMI 37.9 kg/m2, 不合并T2D	CagriSema组	Cagrilintide+司美格鲁肽 0-16w 爬坡后维持 2.4mg QW	2108	68周	20.4%	17.4%	AE：92.3%；SAE：9.8%；AE 导致停止治疗5.9%；消化道 AE：79.6%
								司美格鲁肽组	0-16w 爬坡后维持 2.4mg QW	302		14.9%	11.9%	AE：89.7%；SAE：5.0%；AE 导致停止治疗3.6%；消化道 AE：73.8%
								Cagrilintide组	0-16w 爬坡后维持 2.4mg QW	302		11.5%	8.5%	AE：84.1%；SAE：8.9%；AE 导致停止治疗2.6%；消化道 AE：54.0%
								安慰剂组	安慰剂	705		3.0%		AE：82.3%；SAE：6.1%；AE 导致停止治疗3.5%；消化道 AE：39.9%
							BMI 36.1-36.4 kg/m2, 合并T2D	CagriSema组	Cagrilintide+司美格鲁肽 0-16w 爬坡后维持 2.4mg QW	904	68周	13.7%	10.3%	AE：90.2%；SAE：10.4%；AE 导致停止治疗8.4%；消化道 AE：72.5%
								安慰剂组	安慰剂	302		3.4%		AE：85.4%；SAE：12.9%；AE 导致停止治疗3.0%；消化道 AE：34.4%

资料来源：2025 ADA、开源证券研究所

礼来的 AMYR 单靶药物 eloralintide 疗效数据亮眼，消化道不良反应发生率显著低于 GLP-1 类药物。单药 eloralintide 每周给药，12 周后高剂量组（Dose 4）体重较基线下降约 11.3%（安慰剂调整后 11.1%），腹泻/恶心/呕吐发生率仅 11.1%/8.3%/8.3%，消化道不良反应发生率低于 GLP-1 产品。

图2：针对肥胖患者 eloralintide 疗效数据亮眼



资料来源：礼来官网、2025 ADA

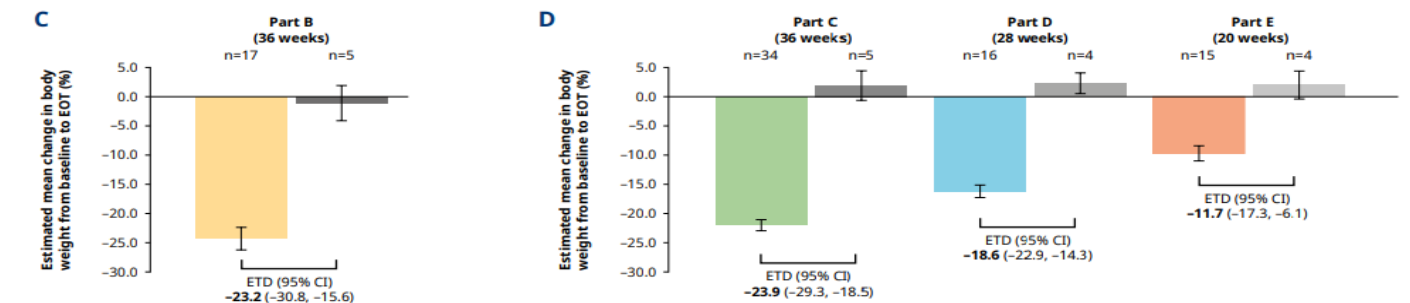
图3：eloralintide 单药消化道不良反应发生率较低

Eloralintide Phase 1 Tolerability					
% of participants with GI AEs	Placebo (N=27)	Dose 2 (N=6)	Dose 3 (N=23)	Dose 4 (N=36)	Overall (N=73)
Decreased appetite	3.7%	16.7%	26.1%	19.4%	19.2%
Diarrhea	0%	16.7%	8.7%	11.1%	9.6%
Nausea	0%	0%	13.0%	8.3%	8.2%
Vomiting	0%	0%	0%	8.3%	4.1%

资料来源：礼来官网、2025 ADA

2025 ADA 大会上，诺和诺德也公布了其 GLP-1R/Amylin 双靶多肽药物 Amycretin-NN9487 的早研数据。单药每周给药，36 周后 20mg 组（Part C）体重较基线下降约 22.0%（安慰剂调整后 23.9%）；20mg 组消化道相关不良反应整体略高于安慰剂组（94% vs 60%），其中恶心（79% vs 40%）、呕吐（53% vs 20%）、腹泻（32% vs 20%）、便秘（44% vs 20%）。Amycretin-NN9487 早研疗效优异，重点关注后续胃肠道相关不良反应，诺和诺德预期 2026Q1 开启减重 III 期临床。

图4：GLP-1R/ Amylin 双靶多肽药物 Amycretin-NN9487 早研数据疗效优异



资料来源：2025 ADA

图5：重点关注 Amycretin-NN9487 后续胃肠道相关不良反应

	Part B				Part C				Part D				Part E			
	Amycretin 60 mg	Placebo	Amycretin 20 mg	Placebo	Amycretin 20 mg	Placebo	Amycretin 5 mg	Placebo	Amycretin 5 mg	Placebo	Amycretin 1.25 mg	Placebo	Amycretin 1.25 mg	Placebo	Amycretin 1.25 mg	Placebo
Number of participants	17	5	34	5	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16	4
TEAEs	17 (100)	5 (100)	29 (85)	5 (100)	19 (100)	4 (100)	13 (81)	4 (100)	13 (81)	4 (100)	13 (81)	4 (100)	13 (81)	4 (100)	13 (81)	4 (100)
SAEs	-	-	1 (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Events leading to withdrawal	6 (35)	8	7 (21)	15	1 (6)	1	1 (6)	1	1 (6)	1	1 (6)	1	1 (6)	1	1 (6)	1
Gastrointestinal AEs	16 (94)	56	32 (94)	113	15 (94)	34	15 (94)	34	15 (94)	34	15 (94)	34	15 (94)	34	15 (94)	34
Nausea	14 (82)	17	27 (79)	36	12 (75)	12	12 (75)	12	12 (75)	12	12 (75)	12	12 (75)	12	12 (75)	12
Vomiting	8 (47)	15	18 (53)	20	4 (25)	5	4 (25)	5	4 (25)	5	4 (25)	5	4 (25)	5	4 (25)	5
Diarrhea	7 (41)	10	11 (32)	13	4 (25)	4	4 (25)	4	4 (25)	4	4 (25)	4	4 (25)	4	4 (25)	4
Constipation	2 (12)	2	15 (44)	16	2 (13)	2	2 (13)	2	2 (13)	2	2 (13)	2	2 (13)	2	2 (13)	2
Dyspepsia	3 (18)	3	12 (35)	12	5 (31)	6	5 (31)	6	5 (31)	6	5 (31)	6	5 (31)	6	5 (31)	6

资料来源：2025 ADA

1.1.2、ActRII: Bimagrumab 初步 POC，打开高质量减重新布局方向

“减脂增肌+代谢修复”有望成为未来减重领域的新标准，与一些特殊靶点的协同联用也有望成为高质量减重下一阶段的发展方向。热门布局靶点主要包括 ActRII（激活素 2 型受体）、MSTN/GDF-8（肌肉生长抑制素）等。

礼来在 2025 ADA 会议上公布了其 ActRII 靶向药物 Bimagrumab 治疗减重的 IIb 期临床数据，结果表明 Bimagrumab 单药 100% 的减重均来自于脂肪，总瘦体重增加了 2.5%；与司美格鲁肽联用时能够有效协同实现体重降低，92.9% 的减重来自脂肪。安全性方面，常见不良反应包括肌肉痉挛、腹泻、痤疮等，ALT 和脂肪酶早期表现出暂时性的升高，整体可控。Bimagrumab 优异的临床数据证明了 ActRII 靶点的临床潜力，也为高质量减重打开了新的布局方向。

图6: Bimagrumab 与 Sema 能够实现有效协同

图7: Bimagrumab 不良反应整体可控

Summary: Efficacy

Endpoint (% change from baseline, unless otherwise specified)	Primary + extension period (Week 72)		
	Bima 30 mg/kg	Sema 2.4 mg	Bima 30 mg/kg + Sema 2.4 mg
Body weight	-10.8%	-15.7%	-22.1%
Fat mass (DXA)	-28.5%	-27.8%	-45.7%
Lean mass (DXA)	+2.5%	-7.4%	-2.9%
Appendicular lean mass (DXA)	+2.3%	-9.2%	-2.6%
% Weight loss due to fat mass (DXA; Week 48)	100%	71.5%	92.9%
% Participants with ≥20% weight reduction	10.9%	25.0%	69.8%
% Participants with ≥30% fat mass reduction (DXA)	50.0%	36.4%	94.0%

Summary: Safety

- Overall, safety results during the primary, placebo-controlled treatment period were consistent with the known safety profiles of the two drugs.
 - Majority of adverse events were mild to moderate in severity.
 - There were no new safety signals during Weeks 48–72.
- Common adverse events (AEs) included muscle spasms, diarrhea, and acne with bimagrumab, and nausea, diarrhea, constipation, and fatigue with semaglutide.
 - Similar events were observed in the 4 combination groups, in which 9% of treated participants discontinued due to AEs over 72 weeks.
 - No deaths were reported.
- Bimagrumab-containing groups showed early and transient increases in ALT and lipase; semaglutide-containing groups had sustained increase in lipase.

资料来源：药融云、2025 ADA

资料来源：药融云、2025 ADA

1.2、口服药物：减重降糖领域下一个风口，有望打开新增量市场

口服 GLP-1RA 类药物的开发为提升患者依从性提供了新的思路。自礼来口服小分子 Orforglipron 的临床数据公布后，口服药物的关注度持续提升，我们预期将成为减重降糖领域下一个风口，有望打开新的增量市场。2025 ADA 大会上，闻泰医药/箕星药业的口服小分子 VCT220、恒瑞医药的 GLP1R/GIPR 双靶药物 HRS9531 片与口服小分子 HRS-7535、Biomed 四靶多肽 GLP1R/GIPR/IGF1R/GCGR、华东医药的口服小分子 Conveglipron(HDM1002)均公布其最新临床数据。

图8：口服 GLP-1RA 类药物的开发为提升患者依从性提供了新的思路，有望打开新的增量市场

管线	公司	靶点	技术形式	给药途径	临床试验编号	临床分期	基线	试验分组	给药方案	N	用药周期	体重减少百分比	相对安慰剂减少	安全性
VCT220	闻泰医药 (orig.)/冀星药业 (lic.)	GLP1R	小分子	口服	NCT06569355	II期	BMI 32.03 kg/m ²	80mg组	0-2w爬坡后维持 80mg QD	250	16周	5.8%	4.2%	最常见的AE与胃肠道相关，严重程度轻至中度，98.0%的参与者表现出良好的依从性。未见与药物相关的SAE
								120mg组	0-4w爬坡后维持 120mg QD			7.4%	5.8%	
								160mg组 (fast)	0-4w爬坡后维持 160mg QD			9.7%	8.1%	
								160mg组 (slow)	0-6w爬坡后维持 160mg QD			9.4%	7.8%	
								安慰剂组	安慰剂			1.6%		
HRS9531片	恒瑞医药 (orig.)	GLP1R GIPR	多肽	口服	NCT06435676	I期	-	10mg组	0-4w 10mg QD	40	4周	4.7%	2.8%	常见TEAE包括高尿酸血症、高甘油三酯血症、恶性等；无SAE
								25mg组	0-2w 10mg；2-4w 25mg QD			5.4%	3.5%	
								安慰剂组	安慰剂			1.9%		
HRS-7535	恒瑞医药 (orig.)	GLP1R	小分子	口服	NCT06250946	II期	BMI 32.5 kg/m ²	30mg组	爬坡至30mg QD	235	26周	3.0%	0.5%	TEAE 试验组87.2%-95.8%，安慰剂组87.0%；大多数TEAE为恶心16.7%-54.2%，腹泻16.7%-21.7%，呕吐15.7%-37.5%，大多为轻中度；2.1%由于TEAE停止治疗
								60mg组	爬坡至60mg QD			7.2%	4.7%	
								120mg组	爬坡至120mg QD			6.2%	3.7%	
								180mg组	爬坡至180mg QD			9.4%	6.9%	
								安慰剂组	安慰剂	-	36周	2.5%		
								180mg组	爬坡至180mg QD			9.5%	8.1%	
Bioglutide (NA-931)	Biomed Industries (orig.)	GLP1R GIPR IGF1R GCGR	多肽	口服	NCT06564753	II期	至少有一种体重相关合并症的肥胖	150 mg组等	150mg QD	-	13周	14.8%	13.2%	所有TEAE均为轻度，所有患者都有轻度恶心与呕吐；腹泻试验组8.1%与3.2%安慰剂组；消化道不良反应试验组与安慰剂组无差异
Conveglipron (HDM1002)	华东医药 (orig.)	GLP1R	小分子	口服	CTR20233390	I期	平均体重 74.1~90.8 kg	50mg QD	50mg QD	60	4周			大多数不良事件 (AEs) 为轻或中度，未报告严重TEAE。常见不良事件为胃肠道相关，绝大多数为轻度恶心和呕吐。所有剂量组中均未报告肝酶升高相关AE
								100mg QD	爬坡至100mg QD					
								200mg QD	爬坡至200mg QD			6.8%		
								100mg BID	爬坡至100mg BID			5.1%		
								400mg QD	爬坡至400mg QD			4.9%		
								安慰剂组	安慰剂					

资料来源：2025 ADA、开源证券研究所

1.3、超长效药物：安进 Maridebart cafraglutide 长周期给药疗效优异

作为长效制剂，司美格鲁肽与替尔泊肽已实现每周给药，相较于每日给药的利拉鲁肽，给药间隔大幅延长。超长效制剂的体内半衰期相对更长，能够实现每 2 周给药甚至每 4 周给药，减少患者的用药频率，简化治疗流程的同时提升患者依从性。

安进的双靶点长效制剂 Maridebart cafraglutide 于 2025 ADA 大会展示其 4 周给药与 8 周给药详细数据，52 周时，420 mg Q4W 与 Q8W (no dose escalation)较基线体重下降分别约 18.9%/17.7%（安慰剂调整后 16.3%/15.1%），长周期给药间隔依然保持良好的临床疗效；随着增加一步递增，呕吐发生率降低，因胃肠道不良反应而停药的比率仅 8%。III 期临床方案中，安进预计通过三步剂量递增给药方案，进一步提升其安全性。

图9：Maridebart cafraglutide 长周期给药间隔依然保持良好的临床疗效

管线	公司	靶点	技术形式	给药途径	临床试验编号	临床分期	基线	试验分组	给药方案	N	用药周期	体重减少百分比	相对安慰剂减少	安全性
Maridebart cafraglutide	安进制药 (orig.)	GLP1R GIPR	其他偶联药物	皮下	NCT05669599	II期	体重 107.4 kg, 不合并T2D	140 mg Q4W	140 mg Q4W (no dose escalation)	465	52周	16.3%	13.7%	随着增加一步剂量递增, 呕吐发生率降低, 因胃肠道不良反应而停药的比例也较低 (8%)
								280 mg Q4W	280 mg Q4W (no dose escalation)			19.9%	17.3%	
								420 mg Q4W	420 mg Q4W (no dose escalation)			18.9%	16.3%	
								420 mg Q8W	420 mg Q8W (no dose escalation)			17.7%	15.1%	
								420 mg Q4W (4W 70 mg one-step dose escalation)	420 mg Q4W (4W 70 mg one-step dose escalation)			16.7%	14.1%	
								420 mg Q4W (12W 70 mg one-step dose escalation)	420 mg Q4W (12W 70 mg one-step dose escalation)			19.9%	17.3%	
								安慰剂组	安慰剂			2.6%		
							合并T2D	140 mg Q4W	140 mg Q4W (no dose escalation)	127	52周	12.3%	10.9%	
								280 mg Q4W	280 mg Q4W (no dose escalation)			12.1%	10.7%	
								420 mg Q4W	420 mg Q4W (no dose escalation)			17.0%	15.6%	
								安慰剂组	安慰剂			1.4%		
RAY1225	众生药业 (orig.)	GLP1R /GIPR	多肽	皮下	NCT06254261	II期	BMI 32.33 kg/m2	3mg组	爬坡至3mg Q2W	132	24周	10.1%	6.4%	最常见的AE是胃肠道相关, 大多数为轻度至中度严重程度, 主要发生在剂量增加期间。未发生与药物相关的严重不良反应
								6mg组	爬坡至6mg Q2W			13.0%	9.4%	
								9mg组	爬坡至9mg Q2W			13.1%	9.4%	
								安慰剂组	安慰剂			3.6%		
依苏帕格鲁肽α	银诺医药 (orig.)	GLP1R	抗体类融合蛋白	皮下	NCT06732960	II期	BMI 33.0 kg/m ²	5.0mg组	0-4w爬坡至5.0mg 组 Q2W	50	4周	6.0%	5.2%	与治疗相关的不良事件主要是轻至中度胃肠道, 没有过早停药、SAEs或高血糖
								7.5mg组	0-4w爬坡至7.5mg 组 Q2W			6.7%	5.8%	
								10.0mg组	0-6w爬坡至 10.0mg组 Q2W			8.8%	7.9%	
								15.0mg组	0-8w爬坡至 15.0mg组 Q2W			6.0%	5.2%	
								20.0mg组	0-12w爬坡至 20.0mg组 Q2W			8.6%	7.8%	
								安慰剂组	安慰剂			0.9%		

资料来源：2025 ADA、开源证券研究所

1.4、单靶/多靶 GLP-1：减重降糖基石药物，持续追求疗效与安全性提升

作为减重降糖领域的基石药物,多款单靶与多靶 GLP1R 靶点药物也在 2025 ADA 大会披露其最新临床数据。诺和诺德的司美格鲁肽首次披露 7.2mg 组减重数据, 72 周不合并糖尿病患者体重较基线下降 18.7% (安慰剂调整后 14.8%), 合并糖尿病患者体重较基线下降 13.2% (安慰剂调整后 9.3%)。恒瑞医药的双靶药物 HRS9531 与华东医药的双靶药物 HDM1005 也均展示出优异的临床数据。

图10：作为减重降糖领域的基石药物，多款单靶与多靶 GLP1R 靶点药物也在 2025 ADA 大会披露其最新临床数据

管线	公司	靶点	技术形式	给药途径	临床试验编号	临床分期	基线	试验分组	给药方案	N	用药周期	体重减少百分比	相对安慰剂减少	安全性
HRS9531	恒瑞医药 (orig.)	GLP1R GIPR	多肽	皮下	NCT05881837	II期	中国患者, BMI 28-40 kg/m ²	1.0mg组	爬坡至1.0mg QW	166	32周	18.0%	17.2%	试验组TEAE约75.5%-91.8%，安慰剂组85.7%，大多数都是轻度，消化不良反应最常见
								3.0mg组	爬坡至3.0mg QW					
								4.5mg组	爬坡至4.5mg QW					
								6.0mg组	爬坡至6.0mg QW					
HRS9531	恒瑞医药 (orig.)	GLP1R GIPR	多肽	皮下	NCT06054698	II期	BMI 31.3 kg/m ²	8.0mg组	爬坡至8.0mg QW	49	36周	22.8%	21.1%	大多数TEAE的严重程度较轻，与胃肠道有关，最常见的是腹泻、恶心和呕吐。没有患者因TEAE而永久停止治疗
								安慰剂组	安慰剂	12		1.7%		
Poterepatide (HDM1005)	华东医药 (orig.)	GLP1R GIPR	多肽	皮下	NCT06640647 NCT06637020	I期	-	MAD 组	0.5-4 mg 剂量爬坡 QW	40	4周	6.12%-10.29%	2.41% - 6.58%	试验组最常见不良反应是食欲下降和胃肠道不良反应（恶心、呕吐和腹胀），呈剂量依赖性，严重程度较轻。无3级低血糖报告，无SAE，无因AE终止事件
								安慰剂组	安慰剂			3.7%		
司美格鲁肽	诺和诺德 (orig.)	GLP1R	多肽	皮下	NCT05649137	III期	BMI 38.6 kg/m ² ，合并T2D	7.2mg组	0-20w爬坡后维持 7.2mg QW	512	72周	13.2%	9.3%	7.2 mg、2.4 mg和pbo的参与者报告的胃肠道AE分别为53.1%、51.5%和25.5%，SAE分别为9.1%、8.7%和8.8%。与2.4 mg或pbo相比，Sema 7.2 mg不会增加低血糖发作的风险
								2.4mg组	0-20w爬坡后维持 2.4mg QW			10.4%	6.5%	
								安慰剂组	安慰剂			3.9%		
司美格鲁肽	诺和诺德 (orig.)	GLP1R	多肽	皮下	NCT05646706	III期	BMI 39.9 kg/m ²	7.2mg组	0-20w爬坡后维持 7.2mg QW	1005	72周	18.7%	14.8%	7.2 mg、2.4 mg和pbo的参与者报告的胃肠道AE分别为70.8%、61.2%和42.8%，SAE分别为6.8%、10.9%和5.5%。AE相关脱组率3.3%、2.0%、0%
								2.4mg组	0-20w爬坡后维持 2.4mg QW	201		15.6%	11.7%	
								安慰剂组	安慰剂	201		3.9%		
MET-097i	Metsera (orig.)/Amneal (lic.)	GLP1R	多肽	皮下	NCT06857617	I期	BMI 31.9 kg/m ²	0.2mg组	0.2mg QW	8	5周	1.9%	1.3%	常见的胃肠道不良反应（恶心/呕吐）大多是轻微的，发生在给药的最初几周内
								0.4mg组	0.4mg QW	8		3.4%	2.8%	
								0.8mg组	0.8mg QW	8		6.3%	5.7%	
								1.0mg组	1.0mg QW	8		7.4%	6.8%	
								1.2mg组	1.2mg QW	9		7.5%	6.9%	
								0.8-1.6mg组	0-4w 0.8mg QW+1.6mg QW	8		6.3%	5.7%	
								安慰剂组	安慰剂	13		0.6%		
MET-097i	Metsera (orig.)/Amneal (lic.)	GLP1R	多肽	皮下	NCT06857617	II期	BMI 31.2 kg/m ²	0.4/0.8/1.2 mg组	0.4-0.8-1.2mg QW 每4周递增	20	14周	5.3%	6.3%	最常见的AE与GI相关（恶心、呕吐、便秘和腹泻），通常剂量依赖，多为轻度/中度。剂量递增组恶心率为5%，呕吐率为10%
								0.6mg组	0.6mg QW	20		6.1%	7.1%	
								0.8mg组	0.8mg QW	20		9.3%	10.3%	
								1.0mg组	1.0mg QW	20		8.8%	9.8%	
								1.2mg组	1.2mg QW	20		10.3%	11.3%	
								安慰剂组	安慰剂	20		增加 1.0%		
伊诺格鲁肽	先为达生物 (orig.)	GLP1R	多肽	皮下	NCT05813795	III期	BMI 32.5 kg/m ²	1.2mg组	爬坡至1.2mg QW	664	48周	9.9%	9.6%	试验组AE 92.8%-93.4%，安慰剂组84.2%。试验组共有10名（2.0%）参与者因AE而停用 ecnoglutide，5名（1.0%）参与者SAE。最常见的AE是食欲下降、腹泻、恶心和呕吐，其严重程度大多为轻至中度和短暂性
								1.8mg组	爬坡至1.8mg QW			13.3%	13.0%	
								2.4mg组	爬坡至2.4mg QW			15.4%	15.1%	
								安慰剂组	安慰剂			0.3%		

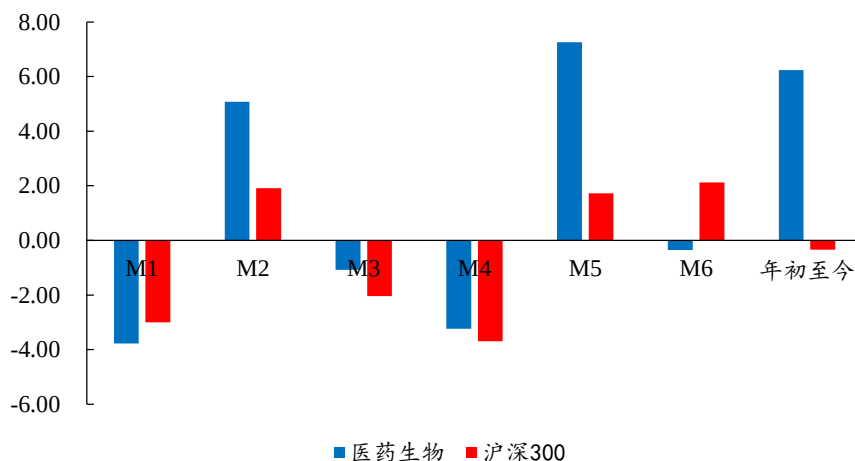
资料来源：2025 ADA、开源证券研究所

2、6月第4周医药生物上涨1.6%，医院子板块涨幅最大

2.1、板块行情：本周医药生物上涨1.6%，跑输沪深300指数0.35pct

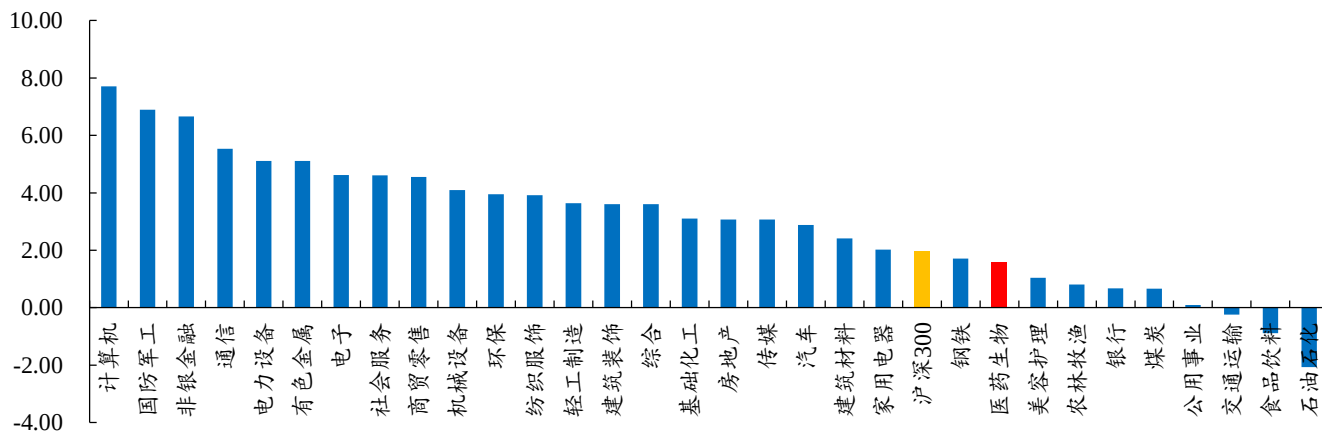
从月度数据来看，2025年初至今沪深整体呈现下行趋势。2025年6月第4周计算机、国防军工等行业涨幅靠前，食品饮料、石油石化等行业涨幅靠后。本周医药生物上涨1.6%，跑输沪深300指数0.35pct，在31个子行业中排名第23位。

图11：6月医药生物指数下跌0.35%（单位：%）



数据来源：Wind、开源证券研究所（截至2025.06.27）

图12：6月第4周医药生物上涨1.6%（单位：%）

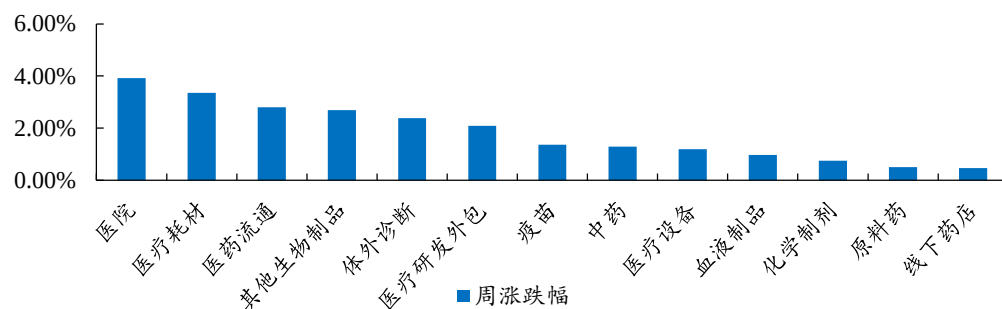


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：2025.06.23-2025.06.27为6月第4周）

2.2、子板块行情：医院板块涨幅最大，线下药店涨幅最小

2025年6月第4周全部板块处于上涨态势，本周医院板块涨幅最大，上涨3.92%；医疗耗材板块上涨3.36%，医药流通板块上涨2.81%，其他生物制品板块上涨2.7%，体外诊断板块上涨2.38%；线下药店板块涨幅最小，上涨0.47%，原料药板块上涨0.51%，化学制剂板块上涨0.75%，血液制品板块上涨0.97%，医疗设备板块上涨1.2%。

图13：医院板块涨幅最大，线下药店涨幅最小



数据来源：Wind、开源证券研究所

表1：6月以来血制品和医疗耗材板块涨幅领先

子板块	M1	M2	M3	M4	M5	M6	年初至今	预测 PE (2025)	预测 PEG (2025)
中药	-4.94%	-1.15%	0.35%	-2.77%	4.39%	-1.61%	-4.59%	20.04	1.61
化学制药	-2.91%	4.68%	1.78%	1.61%	11.31%	0.21%	19.41%	42.23	1.74
原料药	-2.92%	7.53%	-1.31%	-0.93%	10.83%	-0.39%	16.56%	28.95	1.77
化学制剂	-2.90%	4.12%	2.40%	2.10%	11.40%	0.32%	19.97%	45.24	1.74
医药商业	-4.18%	0.72%	0.11%	0.25%	2.75%	-2.15%	-1.02%	13.42	1.02
医药流通	-3.92%	0.33%	-2.04%	-4.25%	3.89%	-1.13%	-4.42%	12.10	1.15
线下药店	-4.84%	1.71%	5.60%	11.12%	0.33%	-4.37%	7.67%	17.39	0.80
医疗器械	-4.29%	6.26%	-4.00%	-5.49%	4.82%	-0.64%	-1.62%	25.01	1.51
医疗设备	-5.34%	10.49%	-6.81%	-3.05%	5.76%	-2.83%	-1.39%	27.09	1.46
医疗耗材	-1.97%	-0.11%	-1.14%	-6.78%	3.15%	2.32%	-2.19%	24.20	1.11
体外诊断	-5.23%	6.26%	-1.64%	-8.83%	4.98%	0.27%	-1.40%	21.13	2.91
生物制品	-3.21%	2.64%	-1.80%	-5.27%	7.42%	-0.73%	2.58%	36.59	0.81
血液制品	-1.58%	-3.50%	0.09%	-3.67%	1.08%	1.25%	-3.50%	20.46	1.56
疫苗	-6.59%	3.66%	-4.86%	-9.52%	4.92%	-0.91%	-9.84%	38.39	0.60
其他生物制品	-1.32%	4.49%	-0.35%	-2.99%	11.37%	-1.30%	14.55%	46.39	0.77
医疗服务	-3.90%	15.16%	-3.78%	-9.92%	5.71%	0.95%	8.10%	26.51	0.91
医院	-6.10%	15.06%	-7.53%	-6.32%	0.47%	1.10%	-0.70%	34.01	1.79
医疗研发外包	-2.34%	11.74%	-0.74%	-11.56%	8.34%	1.14%	11.60%	22.75	0.99

数据来源：Wind、开源证券研究所

表2：子板块中个股涨跌幅（%）前5

		原料药		化学制剂		中药		生物制品		医药商业	
涨幅前5	1	新赣江	11.91	迈威生物-U	17.44	ST 百灵	12.80	神州细胞	30.45	华人健康	25.97
	2	花园生物	9.08	微芯生物	12.19	恩威医药	6.81	百普赛斯	15.79	塞力医疗	14.49
	3	宏源药业	8.38	金城医药	11.46	ST 葫芦娃	6.71	诺思兰德	11.30	漱玉平民	11.95
	4	科源制药	7.28	多瑞医药	10.47	天目药业	5.94	万泽股份	9.91	润达医疗	8.12
	5	美诺华	6.65	联环药业	8.93	济川药业	5.81	金迪克	7.97	达嘉维康	7.44
跌幅前5	1	博瑞医药	(9.36)	易明医药	(21.90)	众生药业	(6.04)	科兴制药	(5.77)	老百姓	(2.15)
	2	圣达生物	(4.29)	福元医药	(11.50)	龙津退	(3.28)	赛升药业	(4.73)	一心堂	(1.75)
						(退市)					
	3	新诺威	(2.52)	悦康药业	(7.74)	昆药集团	(2.45)	艾迪药业	(4.24)	大参林	0.00
	4	新和成	(1.98)	*ST 赛隆	(6.87)	羚锐制药	(0.53)	康希诺	(3.78)	必康退(退市)	0.00
	5	国邦医药	(1.45)	常山药业	(5.93)	江中药业	(0.32)	百济神州-U	(3.59)	百洋医药	0.10
		医疗研发外包		医疗服务		医疗设备		医疗耗材		体外诊断	
涨幅前5	1	南模生物	16.51	迪安诊断	9.79	锦好医疗	16.05	华强科技	22.94	浩欧博	27.08
	2	数字人	12.10	光正眼科	9.02	鹿得医疗	11.34	南卫股份	10.74	东方海洋	10.24
	3	药康生物	11.46	美年健康	7.16	宝莱特	7.68	惠泰医疗	7.91	安必平	10.23
	4	药石科技	8.90	金域医学	6.94	天智航-U	7.58	采纳股份	7.59	硕世生物	7.74
	5	泓博医药	8.14	贝瑞基因	6.81	康众医疗	6.96	春立医疗	7.43	仁度生物	6.24
跌幅前5	1	睿智医药	(4.57)	ST 中珠	(2.91)	开立医疗	(1.00)	济民健康	(3.29)	新产业	(3.55)
	2	百诚医药	(1.19)	创新医疗	(0.77)	迈瑞医疗	(0.27)	山东药玻	(0.36)	博拓生物	(0.27)
	3	诺泰生物	(0.29)	新里程	(0.44)	联影医疗	(0.20)	奥精医疗	(0.16)	圣湘生物	0.25
	4	药明康德	0.86	*ST 生物	1.11	东富龙	0.16	振德医疗	0.24	艾德生物	0.77
	5	和元生物	1.37	通策医疗	1.75	山外山	0.23	大博医疗	0.42	九安医疗	0.78

数据来源：Wind、开源证券研究所

3、风险提示

- (1) 政策波动风险。医保政策、价格调整等政策可能对医药行业产生影响。
- (2) 市场震荡风险。若市场风险偏好改变或公司成长性预期调整，可能影响公司估值稳定性。
- (3) 医保未准入风险。医保谈判结果还未正式落地，还需要以实际医保谈判结果为准。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn